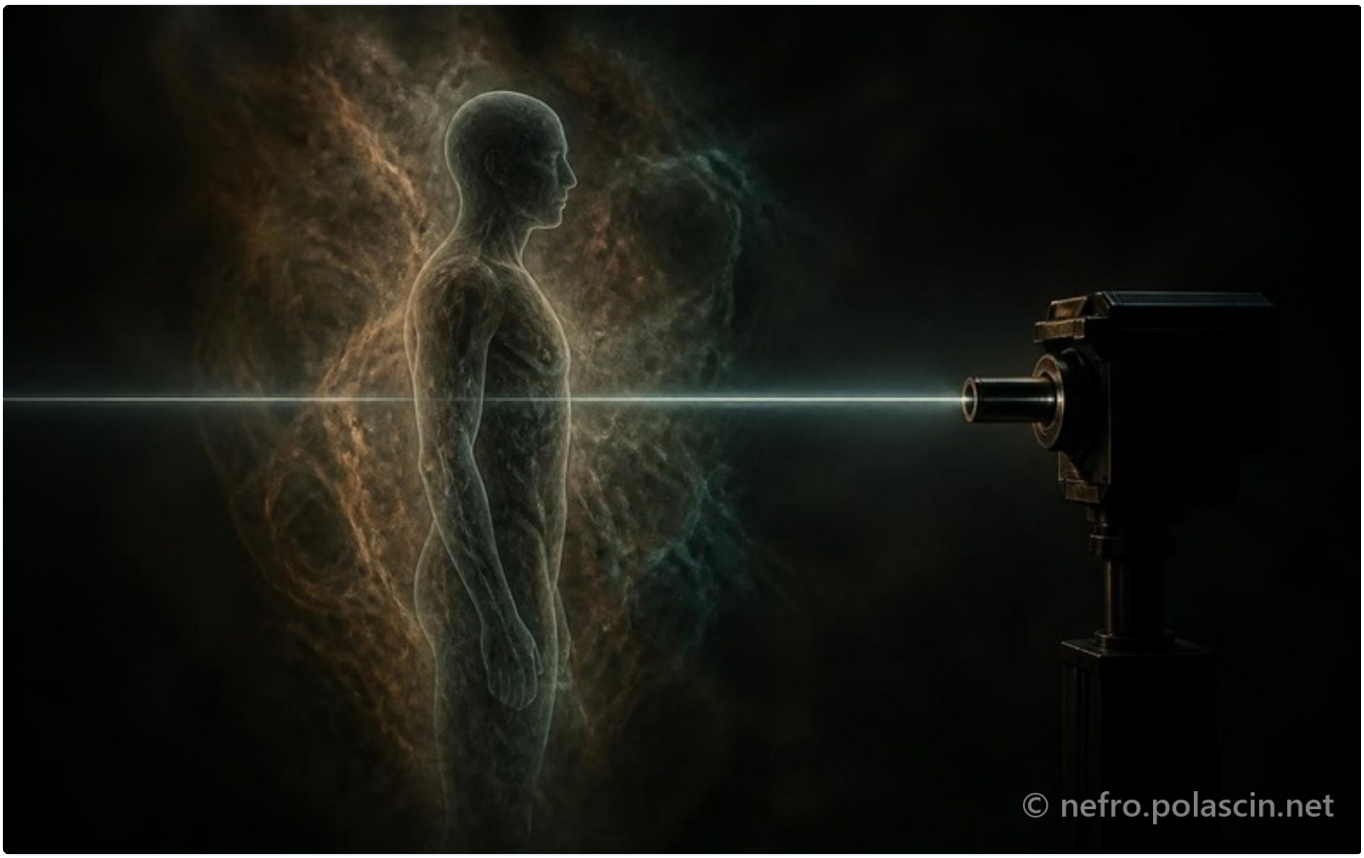
Keď sa cítime chorí: čo medicína prehliada a prečo na tom záleží aj v nefrológii

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 26.06.2026



Ilustračná scéna. To, čo pacient cíti, sa do meraní nepremietne – a predsa to o jeho stave hovorí veľa.

Úvod

Medicína vie v praxi veľmi dobre určiť, „čo je zle“ v tele. Dokáže pomenovať poruchy funkcie orgánov, vysvetliť nálezy a zvoliť liečbu podľa biologického mechanizmu. Existuje však aj druhá vrstva, ktorú vyšetrenia zachytia len ťažko. Ide o **chorobnosť (illness)**, teda skúsenosť, že nie som „svoj“, že moje bežné fungovanie sa narušilo a svet okolo mňa sa začal správať inak.

Tento rozdiel medzi **chorobou (disease)** a **chorobnosťou (illness)** je jadrom celej úvahy: medicína niekedy „nevidí“ to, čo pacient vníma ako skutočne dôležité: prežívanie nepohody, neistotu, stratu rutiny, zmenený vzťah k telu a vplyv na život.

Choroba nie je to isté ako chorobnosť

Často sa pracuje s predstavou, že „ak sa to nedá dokázať nálezom, tak to nie je skutočné“. Autor zdôrazňuje opak: **chorobnosť je skúsenosť**, nie iba súbor merateľných abnormalít. Keď ľudia povedia „som chorý“, zvyčajne nemajú na mysli iba patológiu. Opisujú narušenie bežného života: zmeny v rutine, v schopnostiach, v pocite bezpečia do budúcnosti, v kvalite vzťahov a v tom, ako vnímajú sami seba.

Z toho vyplýva prakticky dôležitý záver: hoci choroba a chorobnosť často idú spolu, **ani jedna nie je úplne závislá od druhej**. Človek môže trpieť a vyšetrenia nedajú jasné vysvetlenie; a naopak, nálezy môžu zodpovedať „chorobnému“ obrazu, kým pacientovo prežívanie nemá rovnakú intenzitu.

Kedy „chorobnosť“ prichádza: skôr, než ju zachytí diagnostika

Človek často vie, že niečo „nie je v poriadku“, **skôr, ako sa začne vyšetrovací proces**. Rozpoznanie sa rodí z

prežívania, z nášho vzťahu k vlastnému telu, z očakávania zdravia a z toho, ako daná kultúra interpretuje príznaky.

V praxi to mení aj otázku „kedy je pacient vlastne chorý?“. Ak diagnóza príde až neskôr, znamená to, že pacient už určitý čas žije v stave, ktorý sa pre medicínu stáva „informáciou na prácu“ až dodatočne. Pacient sa však medzičasom adaptuje, stráca istotu a prežíva nepohodu, ktorá nemusí mať okamžité biologické potvrdenie.

Diagnóza pomáha, ale môže aj zjednodušovať

Diagnostické označenie je užitočné. Dáva spoločný jazyk, umožňuje koordinovať starostlivosť a niekedy nasmerovať liečbu. Autor však upozorňuje aj na riziko: previesť komplexnú skúsenosť na jedinú klinickú kategóriu znamená **odfiltrovať variabilitu a hĺbku prežívania**.

To je v nefrológii obzvlášť citlivé. Pacient s chronickou chorobou obličiek (aj počas dialýzy) často neprežíva iba „ochorenie obličiek“ ako diagnózu. Prežíva kombináciu obmedzení, únavy, kolísania príznakov, vplyvu liečby na organizmus, psychickej záťaže, ale aj zmeny v tom, čo preňho znamená každodennosť. Jedna diagnostická nálepka nikdy nevystihne celé „nie som sám sebou“.

Čo to mení v nefrologickej praxi

Ak prijmeme, že chorobnosť je skúsenosť, a nie iba merateľná odchýlka, má to pre nefrológiu niekoľko praktických dôsledkov.

1) Pacientov opis nie je len „anamnéza na doplnenie“

Keď pacient opíše, že sa „necíti sám sebou“, že trpí, že ho niečo brzdí viac, než by naznačovali čísla, je to klinicky relevantné. Nemusí to automaticky znamenať, že všetko je „psychosomatické“ alebo „nevysvetliteľné“. Skôr to znamená, že v diagnostickom myslení treba aktívne hľadať súvislosti aj v tom, čo sa nedá zachytiť jediným parametrom.

2) Absencia jednoznačných nálezov neznižuje realitu utrpenia

Autor výslovne upozorňuje na paradox: človek prežíva výraznú nepohodu, no vyšetrenia nemusia poskytnúť „dôkaz“. To samo osebe neumenšuje realitu utrpenia. V nefrológii to môže znamenať, že aj pri relatívne stabilných laboratórnych hodnotách pacient prežíva výrazné funkčné obmedzenie, ktoré treba brať vážne a cielene riešiť – symptomaticky, rehabilitáciou, úpravou režimu či liečby, prípadne zhodnotením faktorov, ktoré sa nedajú zúžiť na jediný laboratórny nález (napríklad kvalita spánku, tolerancia liečby, funkčné schopnosti).

3) „Čo diagnóza vysvetlí“ a „čo diagnóza zakryje“ treba vedieť rozlíšiť

Diagnóza osvetlí časť obrazu, no komunikácia aj manažment by mali počítať s tým, že nemusí pokryť všetko, čo pacient prežíva.

Pre klinickú prax to znamená, že je užitočné cielene sa pýtať na vplyv ochorenia na život: čo je pre pacienta dnes najťažšie, čo sa zmenilo, ako liečba ovplyvňuje jeho fungovanie a aké „bariéry“ sa objavili.

4) Prehodnotiť, kam smerujú rozhovory

Ak sa v rozhovore príliš skoro presunie ťažisko len na čísla, pacientovo prežívanie môže zostať nepomenované. Autor uzatvára, že výzvou pre lekárov nie je odmietanie medicínskych vysvetlení, ale **uznanie ich hraníc**. V praxi to znamená vyvážiť:

- objektívne merania,
- a zároveň pozornosť voči tomu, čo pacient prežíva ako chorobnosť.

Záver

Medicína vie chorobu identifikovať veľmi dobre. Ak však chceme človeku skutočne pomôcť, nestačí pomenovať, „čo je zle v tele“. Potrebujeme rozumieť aj tomu, ako sa chorobnosť rodí, ako sa komunikuje a ako diagnózy môžu niečo vysvetliť, ale aj niečo prehliadnuť. V nefrológii to nie je filozofická téma, ale každodenný klinický rozhodovací rámec: kvalita starostlivosti sa často zlepšuje práve vtedy, keď pacientovo „nie som sám sebou“ berieme ako relevantný klinický signál, nie ako vedľajší šum.

Poznámka: *Tento článok má vzdelávací a osvetový charakter a nenahrádza individuálne klinické rozhodovanie ošetrujúceho tímu.*

Zdroje

1. Arya Anthony Kamyab. „What Medicine Misses When You Feel Ill“ (o rozdiele medzi *disease* a *illness*). *Medscape*, 2026. Link na zdroj.
2. Christopher D. Ward. *Between Sickness and Health: The Landscape of Illness and Wellness*. 1. vydanie. Routledge, 2020. Informácie o knihe.

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=ked-sa-citime-chori-co-medicina-prehliada-nefrologia · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.